

RECURSO CÍVEL Nº 5061942-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: OSMUNDO PEREIRA RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRANSPLANTE DE LINFONODOS. NÃO COBERTURA PELO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendo a sua exigibilidade por se tratar de recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5061942-36.2024.4.02.5101

510015417717 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5061942-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: OSMUNDO PEREIRA RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transplante de linfonodos.

O recorrente alega, em suma, que a demora na realização do procedimento cirúrgico pode agravar a doença, impactando negativamente seu quadro clínico e até mesmo resultando na ineficácia de um tratamento tardio, bem como menciona que não tem condições financeiras de arcar com as despesas médicas necessárias. Postula a reforma e a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso porque presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Em ações referentes a tratamento de saúde, imperioso destacar o preceito do artigo 196 da Constituição da República, de eficácia imediata, o qual revela que *"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação"*.

A menção a "Estado", no dispositivo citado, mostra-se abrangente, de forma a alcançar a União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Nesse sentido, resta configurada a responsabilidade solidária dos entes federativos no tocante ao fornecimento de medicamento.

Isso porque a repartição de competências e a descentralização das atribuições não podem servir de argumentos para o fim de se eximir da responsabilidade solidária amplamente reconhecida na jurisprudência do Pretório Excelso, já que a organização administrativa do Estado não pode constituir óbices ao direito à saúde, vertente do princípio da dignidade humana.

Nem se deve cogitar em abalo às finanças públicas ou violação ao princípio da eficiência ou da reserva atendimento/tratamento médico pleiteado, com vistas à garantia constitucional da inviolabilidade do direito à saúde, não havendo, pois, como deixar de privilegiar os bens jurídicos ora tutelados por motivos de ordem financeira e orçamentária.

Sabe-se que, em regra, não deve haver interferências casuísticas do Judiciário na distribuição de medicamentos ou na prestação de saúde por meio de tratamentos padronizados, tendo em vista que tal gestão deve observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às políticas de saúde pública, visando a repartição dos recursos de forma mais eficiente e não individualizada, sob pena do colapso da prestação de saúde pública.

Contudo, casos há em que a intervenção do Poder Judiciário se torna necessária para tutelar o direito à saúde e à vida, diante da inexistência, ineficiência ou ineficácia da atuação da Administração Pública na prestação dos direitos fundamentais, sendo necessário analisar o caso concreto.

No caso em questão, o recorrente foi diagnosticado com câncer de pênis, submetido a penectomia parcial + linfadenectomia inguinal bilateral, evoluiu com sequela do tratamento com linfedema em região escrotal volumosa, necessitando de transplante de linfonodos (evento 1-ANEXO2, fl. 28).

De acordo com o parecer do NAT (evento 16):

"(...) Diante do exposto, informa-se que o transplante de linfonodos está indicado ao tratamento do quadro clínico apresentado pelo Autor - linfedema de bolsa escrotal secundário a neoplasia maligna de pênis (Evento 1, ANEXO2, Página 28). Contudo, não se encontra coberto pelo SUS, conforme a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS (SIGTAP), tornando inviável a sua obtenção pelas vias administrativas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

Informa-se que tal procedimento não foi avaliado pela CONITEC, bem como não está contemplado em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde.

No que tange ao Sistema Nacional de Transplantes (SNT) cuja função de órgão central é exercida pelo Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes, com o objetivo de desenvolver o processo de doação, captação e distribuição de órgãos, tecidos e células-tronco hematopoéticas para fins terapêuticos. A relação dos tipos de transplantes não contempla o item pleiteado.

Adicionalmente, foram realizadas consultas às plataformas do Sistema Estadual de Regulação (SER)1 e do SISREG III, contudo, não foi encontrada nenhuma solicitação para o Autor referente a este pleito."

Assim, conforme parecer do NAT, o transplante de linfonodos não está coberto pelo SUS, não foi avaliado pela CONITEC e não está contemplado em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. Também não consta no Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e não foi encontrada nenhuma solicitação no Sistema Estadual de Regulação e do SISREG III com relação a esse pleito.

Ademais, a parte autora juntou o laudo médico para tratamento fora de domicílio interestadual e relatórios médicos (evento 1-ANEXO2, fls. 28 e 35-36), mas não há menção acerca de urgência, nem sobre imprescindibilidade do tratamento. Também não há o valor do transplante de linfonodos na rede privada.

Portanto, não restou comprovada a imprescindibilidade do transplante de linfonodos, para o tratamento do quadro clínico do autor, devendo, por isso, ser mantida a sentença de improcedência tal como proferida (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e art. 1º da Lei nº 10.259/2001).

Tal o contexto, indefiro a antecipação da tutela recursal.

Pelo exposto, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso interposto, mantendo-se a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Condene o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendo a sua exigibilidade por se tratar de recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. **Intimem-se.** Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se ao Juízo de origem.

